3.临床特点

杂音：部位：二尖瓣的问题（心尖部听）、三尖瓣的问题（胸骨左缘4-5肋间听）、室间隔的问题（胸骨左缘3-4肋间听）；时期：如二尖瓣关闭不全（收缩期听）

①起病隐匿 ttsx 左心衰一定要看肺

②**左心衰（肺淤血水肿）或全心衰**。左心衰发展到全心衰后呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻 右心射血↓

③**心尖或胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音** 左心扩大→相对性二尖瓣关闭不全→心尖部收缩期杂音；右心扩大→相对性三尖瓣关闭不全→胸骨左缘4-5肋间收缩期杂音

④导致**收缩性心衰**（超声心动图 **LVEF≤40%**）

可能可能最可能：心界常向两侧扩大、左心衰或全心衰

4.治疗

①**同慢性心衰**，首选 **β-R 拮抗剂**（免疫介导患者有抗 β_1-R 抗体→持续激动 β_1-R 致脱敏）

②伴快速房颤可用强心苷（抑制房室结传导），即解决收缩性心衰收缩能力下降的问题又解决房颤可能从房室结传下来引起室颤的问题

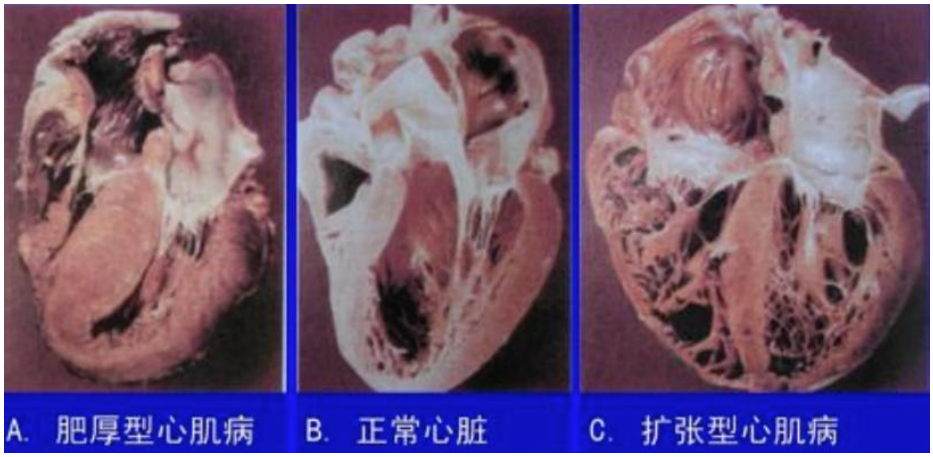
③携带高危致病基因为猝死高危、即使其 LVEF＞35%也应考虑植入型心律转复除颤器 ICD 一级预防

注意：肥心病和扩心病均可：

①猝死：**ICD 预防**

②房颤等心律失常、栓塞（附壁血栓脱落），病理 Q 波、ST 段压低、T 波倒置

③**超声心动图**：首选和金标准



三、限制型心肌病 VS 缩窄性心包炎

1.共性 二者理论上来说都会限制左心和右心，但由于肺循环容量较小，体循环容量巨大，所以右心衰表现更突出

①体循环回流障碍（颈静脉怒张等），心界不大或稍大，舒张性心衰

②**超声心动图**：首选和金标准

2.区别

	限制型心肌病	缩窄性心包炎
病因	淀粉样变等	结核、急性非特异性心包炎等 渗出纤维素
病理	心内膜及心内膜下心肌纤维化（内衣太紧）	心包粘连增厚、钙化（外套太紧）
体征	**无奇脉** 奇脉：严重的色魔小说包邮	可有奇脉、**心包叩击音**（特点）、心包积液也有 **负性心尖搏动**、室间隔抖动征=奇脉 严重的右心室增大（顺钟向转位）

缩窄性心包炎：极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓；极度吸气→胸腔负压↑（又吸气又吸血↑）→回右心血↑→室间隔向左推 → 左室血↓↓→搏出量↓↓→奇脉/吸停脉

限制性心肌病：心内膜纤维化（封住室间隔），无摆动，故无奇脉/吸停脉